

Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет

им. акад. Павлова

Кафедра: пропедевтики внутренних болезней с клиникой
имени академика М.Д.Тушинского

Зав. Кафедры: д.м.н. профессор Куликов Александр
Николаевич

Надежда
~~Фрагмент истории болезни~~
Александр

Пациент: Паляница Валентин Иванович, 64 года

Дата поступления в стационар: 09.04.2026

Подготовила:

Студентка 365 гр.

Махмуд Нада

Проверил преподаватель:

???

и/о дата 04.05.2026
проверена 08.05.2026 - (28) А
исправить, сдать вместе с этой историей

жалобы и физикальное исследование
дословно как у Аннаевой Мерзужен
Афанасовой
Куриетовой
Санкт-Петербург

2026 г.

I. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ

- Паляница Валентин Иванович
- Дата рождения: 02.08.1961 (64 года)
- Социальный статус: военный пенсионер
- Дата поступления: 09.04.2026
- Дата курации:

II. ЖАЛОБЫ

1. Аритмия (мерцательная)

Пациент отмечает эпизоды нерегулярного сердцебиения, описывает как «перебои»

Продолжительность около 15–20 секунд

Возникают время от времени, чаще в покое

Проходят самостоятельно

Иногда сопровождаются нехваткой воздуха и беспокойством

2. Одышка

Появляется при нагрузке, иногда беспокоит и в покое

Чаше усиливается ночью

3. Приступы удушья ночью

Пациент просыпается из-за нехватки воздуха, садится

Длительность до 5 минут

Могут повторяться несколько раз за ночь (до 3–5)

~~По характеру напоминают сердечную астму~~

4. Повышенное артериальное давление

Ранее поднималось до 220 мм рт. ст.

Последние значения:

вчера — около 150 мм рт. ст.

сегодня — около 120 мм рт. ст.

Сопровождается головной болью и слабостью

5. Выпячивание в области живота

Расположено на передней брюшной стенке

Постепенно увеличивается (с 2024 года)

Безболезненное

для контроля?

III. АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Болеет с 2023 года, когда перенёс инфаркт миокарда, за медицинской помощью тогда не обращался. О факте инфаркта узнал позже, в 2024 году, при повторном эпизоде.

Во время инфаркта были:

- боль в груди
- резкая слабость
- потеря сознания
- нарушение ритма

Когда это? в 2023 или в 2024?

был госпитализирован? куда?

После повторного инфаркта выполнено стентирование коронарных

артерий. С этого времени появились жалобы на аритмию, усилилась одышка и начали беспокоить ночные приступы удушья.

Потом в чужую страну?

Проходил лечение в стационаре г. Великий Новгород. После выписки принимает медикаменты:

- апиксабан
- бисопролол
- валсартан
- фуросемид
- аторвастатин
- амиодарон (при необходимости)

Когда?

с какого года? АД?

Контроль артериального давления нерегулярный. Обычно значения 140–150 мм рт. ст., иногда повышались до 220 мм рт. ст., что сопровождалось ухудшением самочувствия.

В настоящее время сохраняются:

- эпизоды аритмии
- признаки прогрессирования сердечной недостаточности

→ какие конкретно
расширять
диету
и т.д.

09.04.2026 направлен в ПСПбГМУ им. Павлова для дообследования и лечения. ~~Медицинские документы не предоставлены.~~

IV. ИСТОРИЯ ЖИЗНИ

Год рождения — 1961

Служил в армии, работал в военной сфере, сейчас на пенсии

Перенесённые заболевания:

- 1988 — аппендэктомия
- 2023 — инфаркт миокарда
- 2024 — повторный инфаркт

Сопутствующая патология: ХОБЛ

Вредные привычки:

- Длительно курил (с 15 лет, более 40 лет стажа)

Виктор
После инфаркта отказался от курения

интервью

Это не вся жизнь:

какие-то вещи?
страховка?
интервью?

Органы по состоянию и органам?

V. ОБЪЕКТИВНЫЙ СТАТУС

Общее состояние — средней тяжести *на основании чего?*

Сознание ясное

Кожные покровы без особенностей

Дыхательная система:

- дыхание везикулярное
- хрипов нет
- ЧДД в норме

Сердечно-сосудистая система:

- ритм неправильный
- тоны сердца приглушены
- возможно наличие дополнительного тона (S3)
- пульс нерегулярный
- АД 130–150 мм рт. ст. (ранее до 220 мм рт. ст.), ГБ III стадия, риск 4

*нормальная
пальцев, пульсация
функционального
мерцательной
ССС: ост, паша, пер, адр
ДС: ост, паша, пер, адр
пульс: рит, паша, пер, адр
МВС: - - -*

Взвешивать аргументы и обосновать диагноз

VI. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Основное заболевание:

- ИБС
- Постинфарктный кардиосклероз
- Инфаркты (2023, 2024 гг.)

Осложнения:

- мерцательная аритмия
- ХСН II–III ФК
- пароксизмальная ночная одышка

Сопутствующие заболевания:

- ХОБЛ

- гипертоническая болезнь III стадии, риск 4
- грыжа передней брюшной стенки

VII. ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. ЭКГ
2. Суточный мониторинг ЭКГ
3. ЭхоКГ
4. Рентген ОГК
5. ОАК, ОАМ
6. Биохимический анализ крови
7. Спирометрия

*обосновать
каждое*

IX. КЛИНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие заболевания связано с длительной артериальной гипертензией и многолетним курением. Эти факторы привели к развитию атеросклероза коронарных артерий, что стало причиной инфаркта миокарда. Недостаточный контроль состояния и отсутствие полноценного лечения способствовали повторному инфаркту. Дополнительно ситуацию ухудшает ХОБЛ, увеличивающая нагрузку на сердечно-сосудистую систему.